

وزارة الصحة العراقية
Iraqi Ministry of Health
Founded 1920 تأسست

الدليل الوطني للمراكز الودية للمسن



العراق ٢٠٢١

الدليل الوطني للمراكز الودية للـــــمسن



قسم الوقاية والسيطرة على الأمراض غير الانتقالية

شـعبة صـــحة الكـــبار

٢٠٢١

Contributers to the age friendly PHC toolkit:

- **Dr. Bushra Ibrahim Abd Al Lattif / MSc in Community Medicine, Primary Health Care Depatment, Directorate of Public Health, NCD Section/ Manager of Elderly Health section/ MoH.**
- **Dr. Batool A Hasan, Director of Muscloskeletal Disease Prevention Unit, NCD Prevention and control Department, Directorate of Public Health, MoH.**
- **Dr. Sally Alaa Witwit, Director of Elderly Health Care Unit, NCD Prevention and Control Department, Directorate of Public Health, MoH.**
- **Dr. Alyaa Idrees Alderzi, Director of Elderly Community Care Unit, NCD Prevention and Control Department, Directorate of Public Health, MoH.**
- **Dr. Muna Attalla Khaleefa Ali, FICMS/ Community Medicine, Director of Non Communicable Depatment / MoH.**
- **Dr. Nada Abdul Wahhab Mousa / Public health senior specialist. PhD Community Medicine/ MoH PHD NCD department.**
- **Dr. Wasan A Rasheed, Director of Nutritional counseling Section, Nutrition Research Institute.**
- **Dr. Iman Jasim Muhammed Al_Akkam/ High degree Diploma in Internal Medicine/ Bachelor's in Medicine and Surgery/ Specialist in Internal Medicine/ Manager.B.CH.B.DM/ Manager of Geriatric Clinic in Baghdad Teaching Hospital.**
- **Dr. Tariq Jassim Mohammed /DRMR specialist of Rheumatology and Medical Rehabilitation/ Baghdad AL Karkh/ Health Directorate AL Karkh/ General Hospital MoH.**
- **Dr. Abdul Razzaq Ali Qaraghuli/ Iraqi Board in Community Medicine/ Vaccine Safety Dept. Manager EPI/ MoH.**
- **Dr. Raghad Ezzat AbdulRazzaq/ MBchB CAMBs/ Arab Board of Health Specialization Community/ The National Center of Training and Development.**

- **Dr. Waseem Gailan Shakir AlBayati/deputy director of the Iraqi Tobacco Combat Program/ Non communicable diseases control department/ Public Health Directorate.**
- **Dr. Zaid Wajih Awad/ Community Medicine- FETP/Graduate/ NCD department/ Director of Mental Health Section.**
- **Dr. Noor Mohammed Ali Wahhoodee/ Family Doctor Specialist/ Manager of Awareness/ Department of Media and Awareness/ M.o.H.**
- **Dr. Faris Abdulkareem Khazaal/ CABM FRCP.ED/ Prof. and Consultant Physian/ Alkindy College of Medicine.**
- **Dr. Muntadar Saad Jabir/ Family Physician/ The Head of the Training and Human Development Center/ M.o.H.**
- **Dr. Haider Hashim Abulmaali/ MD, Microbiologist/ MBChB, MSc/ Primary Health Care Department and Family Medicine Department.**

Administrative staff:

- **Shatha Hassan Mahdi/ Senior Programmer Chief.**
- **Fawzia Ghaleb Mosafir/ Typist Chief.**
- **Samr Khalid Makhlif/ Senior Medical Assistant.**

الفهرست

المقدمة ---------- ص٥

اولا التشيخ الصحي (الطبيعي) ---------- ص٧

ثانيــاً الاتصال مع الكبار ---------- ص١٢

ثالثــاً تعزيز الصحة في المركز الودي للمسن ---------- ص١٦

١. إجراءات الخدمات الوقائية للكبار ---------- ص١٦

٢.السياقات العامة التي تؤخذ بالاعتبار حول اعطاء المشورة السريرية ---------- ص١٧

٣. ادخال خدمات التحرر من التبغ ضمن الرعاية الصحية الاولية ---------- ص١٩

٤. المشورة حول النشاط البدني ---------- ص٢٤

٥. اساسيات المشورة عن التغذية ---------- ص٢٨

رابعــاً المشاكل العملاقة في مرحلة الشيخوخة ---------- ص٢٩

١- الفحص الشامل ---------- ص ٣٢
٢- التقييم السريري والعلاجي للمشاكل العملاقة لكبار السن ---------- ص ٣٥

مخطط لمعالجة المشاكل الصحية للكبار في المراكز الصحية ---------- ص٣٦

الاداة ١: (tool 1) فحص العشرة دقائق الشامل ---------- ص ٣٧

١- Memory Loss---------- ص٤٠
Tool 2-: Mini-mental state examination---------- ص٤١
Tool 3: Memory loss evaluation form ---------- ص ٤٤
٢- depression ---------- ص ٤٥
الاداة ٤ (tool 4) مقياس الاكتئاب لدى المسنين ---------- ص ٤٦
٣- Urinary Incontinence ---------- ص ٤٧
الاداة ٥ (tool 5) تقييم السلس البولي ---------- ص ٤٨
٤- falls ---------- ص ٥٠
الاداة ٦ (tool6) تقييم السقوط ---------- ص ٥١
الاداة ٧ (tool7) أنشطة تقييم الحياة اليومية ---------- ص ٥٣

٣- التقييم السريري والعلاجي للامراض المزمنة لدى الكبار ---------- ص ٥٤

Hypertension and Diabetes ---------- ص ٥٤

Initiation of treatment for hypertension and diabetes in older people ---- ص ٦٠

استمارة الاشراف المركزي والمحلي للمركز الصحي الودي للكبار ---------- ص ٦٢

فيروس كورونا وكبار السن ---------- ص ٦٣

المصادر ---------- ص٦٥

ABBREVIATIONS

ACE	Angiotensin-Converting Enzyme
ACI	Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors
A1C	Hemoglobin A1C
ARB	Angiotensin Receptor Blockers
BB	Beta Blockers
BP	Blood Pressure
CCB	Calcium Channel Blocker
CVD	Cardiovascular Disease
DASH	Dietary Approaches to Stop Hypertension
DBP	Diastolic Blood Pressure
DP4I	Dipeptidyl peptidase -4 inhibitor
DM	Diabetes Mellitus
EKG	Electrocardiogram
FBS	Fasting Blood Sugar
GLP1 A	Glucagon Like Peptide-1 receptor Agonist
HT	Hypertension
SBP	Systolic Blood Pressure
SGL2 I	
SMBG	Self-monitoring of blood glucose
TSH	Thyroid Stimulating Hormone
PP	Pulse Pressure
RBS	Random Blood Pressure

المُـــقدمة :-

يهدف مشروع منظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية المراعية للسن ، لتوعية وتثقيف عاملي مراكز الرعاية الصحية الاولية حول الحاجات الاساسية للمراجعين من الكبار , يشير رمز الرعاية الصحية الاولية المراعية للسن الى العمل في ثلاث مجالات رئيسية :

١- تحفيز وتثقيف وتدريب مقدمي الرعاية الصحية كي يتمكنوا من تقييم ومعالجة الحالات التي تواجه الكبار ومساعدتهم على البقاء بصحة جيدة .
٢- تكييف انظمة ادارة الرعاية الصحية الاولية لتلبية حاجات كبار السن .
٣- البيئة المادية وتسهيل وصول الكبار الذين يعانون من ضعف الحركة او البصر او السمع الى المراكز

١-المبادئ العامة في مجالات المعلومات ، التثقيف والتدريب :

١- يجب على جميع عاملي مراكز الرعاية الصحية الاولية الحصول على التدريب الاساسي في رعاية الكبار فيما يخص المعرفة والمواقف والمهارات المراعية للعمر ، والجنس ، والثقافة.
٢- يجب ان توفر مراكز الرعاية الصحية الاولية التثقيف الملائم حول تحسين الصحة ومعالجة المرض ، وتؤمن الادوية للاشخاص المسنين متابعة استخدام الادوية والممارسات اليومية.

٢-المبادئ العامة في مجال انظمة ادارة الرعاية الصحية المجتمعية :

١- يجب ان تكون الانظمة مراعية للكلفة لكي يسهل الحصول على الخدمة لذوي الدخل المحدود .
٢- يجب ان تكون الاجراءات الادارية متكيفة مع الحاجات الخاصة للمسن متضمنة ذوي المستويات التعليمية المنخفضة او ضعيفي الادراك .
٣- يجب ان تتبنى الرعاية الصحية الاولية الانظمة التي تضمن الاستمرارية في الرعاية ضمن المجتمع من
جهة وبين المجتمع ومستويات الرعاية الثانوية والثالثية من جهة اخرى .
٤- دراسة تطبيق الاليات التي تسهل الرعاية المنزلية والمجتمعية .

٣-المبادئ العامة في مجال البيئة المادية :

١- توفر النقل الامن منخفض الكلفة الى مراكز الرعاية الصحية الاولية .
٢- يجب ان تنشر في كافة انحاء مراكز الرعاية الصحية الاولية لافتات بسيطة وسهلة القراءة لتسهيل التوجه للكبار والتعريف بمقدمي الخدمة .
٣- الاضاءة الجيدة الارضيات المانعة للانزلاق ، الاثاث الثابت.
٤- جميع مرافق مراكز الرعاية الصحية الاولية ان تكون نظيفة ومريحة بكافة انحائها .
٥- توفر المساند والحمامات الغربية الثابتة او المتحركة .



أولا التشيخ الصحى (الطبيعى)

الشيخوخة

- ليست مرض هي مرحلة اذ يمر الجسم البشري بتغيرات تدريجية لكنها مستمرة طوال الحياة.
- لايمكن ايقاف هذه التغيرات او منعها
- يمكن تقليل وتأخير تأثيراتها على وظائف الجسم
- لايوجد عمر معين لبدء الشيخوخة الا ان عمر ٦٠ يعتبر عمر بدء الشيخوخة .





العوامل التى تؤثر على التشيخ :

- العوامل الوراثية
- التغذية
- انماط الحياة الصحية
- الدعم الاجتماعي
- البيئة
- الحالة النفسية
- الامراض العضوية الجسدية





تقل الحواس الخمس

- السمع
- البصر
- التذوق
- الشم
- اللمس



التغيرات في العضلات والعظام :

- نقص في قوة العضلات وقلة مرونتها
- نقص في الكالسيوم نقص في كتلة العظم
- زيادة خطورة الاصابة بالسقوط والكسور
- ضعف التناغم الحركي للعضلات



التغيرات التي تصيب الجلد :

- اعادة توزيع الدهون في الجسم
- ظهور التجاعيد
- الجلد جاف اقل مرونة ، قشري ، رقيق
- الاضافر خشنة ومتقصفة



التغيرات في القلب والرئتين :

- تصبح الرئتين اقل مرونة
- تقل قوة العضلات
- زيادة خطورة الاصابة بالالتهابات

التغيرات فى التبول :-



- ضعف عضلات المثانة
- تقل قابلية السيطرة على التبول
- زيادة مرات الذهاب الى الحمام
- تضخم البروستات
- زيادة خطر الالتهاب

التغيرات فى عملية الهضم:



- تقل حاسة التذوق ، الشم
- يقل افراز اللعاب
- تقل حموضة المعدة مما يؤدي الى تعسر الهضم
- تقل الشهية
- يقل الامتصاص
- تقل حركة الامعاء مما يؤدي الى الامساك
- مشاكل تتعلق بمضغ الطعام ومشاكل الفم والاسنان

التغيرات العقلية:-



- زيادة خطورة الاكتئاب
- ضعف الذاكرة
- ضعف التفاعل
- قلة خلايا الدماغ



اهتمامات كبار السن

- الاعمال البيتية
- السفر
- الصحة
- العلاقات الاسرية
- الاحفاد
- العلاقات الاجتماعية

التكيف مع ضعف البصر:



- استعمال المساند وتحديد السلم بالشريط التوضيحي
- الاضاءة الجيدة
- اعطاء الوقت الكافي للتكيف مع التغير في الاضاءة
- حفظ الحاجيات المهمة في نفس الاماكن
- متابعة حدة البصر
- ارتداء النظارات الطبية
- ابقاء الطريق سالك وواضح

التكيف مع ضعف السمع :-



- الجلوس بمستوى الوجه
- عدم تغطية الفم
- عدم رفع الصوت
- التحدث ببطئ بصوت وكلمات واضحة ومختصرة
- تقليل الفوضى
- الفحص الدوري
- استعمال السماعات



التكيف مع ضعف الشم والتذوق :-

- تقليل استعمال الملح والسكر
- استعمال التوابل للنكهات
- الحفاظ على نظافة الفم والاسنان
- الابتعاد عن التدخين والمدخنين



التكيف مع ضعف حاسة اللمس :-

- اختبار درجة الحرارة للماء
- وضع علامات واضحة للماء الحار والبارد
- الانتباه دائما لوجود جروح
- استعمال احذية مريحة ومربوطة جيدا

التغيرات التي تصاحب التقدم بالعمر من الممكن مواجهتها والتكيف لها ولهذا كبير السن ممكن ان يعيش سعيد ، وبصحة جيدة وعنصر فعال في المجتمع

ثانيا الاتصال مع الكبار

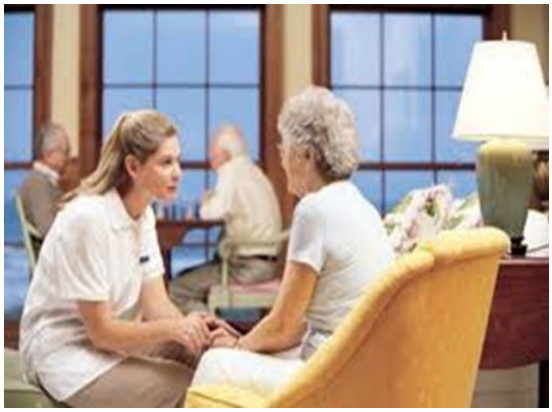


اعطاء واستقبال المعلومات

لماذا الاتصال مهم لكل شخص ؟

- لانه اساس العلاقات الانسانية





مكونات الاتصال :-



- الرسالة
- المرسل
- المستقبل
- الوسيلة
- الاستجابة (التغذية الراجعة)

انواع الاتصال :-

١- اللغوي او اللفظي

٢- غير اللفظي



الاتصال اللفظي :-

هو تبادل اللغة المنطوقة بين اطراف الاتصال ، للوصول إلى اكبر عدد من الفهم المشترك للمعنى الذي تثيره الالفاظ لدى اطراف الاتصال.
(الكلام واللغة)





الاتصال غير اللفظي :

- هي العملية التي يتم من خلالها تبادل الافكار والمعاني بين الافراد بدون اللفظ.
- لغة الجسد ، الصور ، الكتابات ،الاشارات، الصمت.



الاتصال اللفظي يمثل ٧% من انواع الاتصال بينما الاتصال غير اللفظي يمثل ٩٣%

عند الاتصال مع الكبار يجب مراعاة ما يلي :



- الخلفية الاجتماعية ، الثقافية والتعليمية
- اللغة واللهجة
- الحالة العاطفية
- الامراض : الخرف ، باركنسون والسكتة الدماغية
- التغيرات الفزيولوجية
- التفاعل
- الانشغال بمواضيع اخرى

التغيرات الفزيولوجية لدى كبار السن :

الاتصال يتم عن طريق جميع الحواس ، اي تغيير او ضعف في الحواس يؤثر على الاتصال مع الكبار



- البصر
- السمع
- اللمس
- الشم

- الادراك
- عدم التوازن
- الحزن ، العصبية والقلق

انت في حالة الاتصال مع الكبار

شعورك، توقعاتك ، استقبالك يعتمد على :

- خبرتك السابقة
- تفهم الكبار
- معرفتك بالكبار والتشيخ

ثالثـا تعزيز الصحة

تعزيز الصحة في المراكز الودية للمسن .

الهدف العام :

هذا الفصل يهدف لتدريب الملاكات العاملة حول التوجهات والادوات الضرورية لتوفيرالخدمات الصحية الوقائية وخاصة المشورة السلوكية لعوامل الخطورة الثلاث الرئيسية : التدخين ، الخمول البدني ،الغذاء الغير الصحي.

١. اجراءات حول الخدمات الوقائية للكبار

- لابد ان تكون لاطباء الرعاية الصحية الاولية الفرص لتغيير السلوك والتوجهات لكبار السن بخصوص عوامل الخطورة (الخمول البدني ، الغذاء غير الصحي ، التدخين) والتي تعتبر من المسببات الاساسية للامراض والاعاقة .
- ولابد من الحفاظ على انماط الحياة الصحية للكبير والتي تعتبرالمكون الاساسة للصحة الجيدة في الكبر

جدول الخدمات الوقائية

الخدمات الوقائية	الفترة الزمنية
قياس ضغط الدم، الطول،الوزن	كل زيارة
السمنة	كل ثلاثة اشهر
كوليسترول ،الدهون	سنوياً
الكشف عن سرطان عنق الرحم(Pap smear)	3-1 سنة
اشعة الثدي(Mammography)	2-1 سنة
هشاشة العظام	روتين للنساء بعد ٦٥ سنة وللرجال بعد ٧٠ سنة مع مراعاة موجبات الاحالة للاعمار دون ذلك
السمع والبصر	١-٢ سنة

التلقيحات

تعتبر فئة كبار السن من الفئات المستهدفة بالاجراءات الوقائية وخصوصاً اللقاحات الضرورية ضد الامراض التي تهدد صحتهم العامة مع وجود امراض مزمنة في اغلب هذه الفئات العمرية ويتم شمولهم باللقاحات التالية

نوع اللقاح	الفترة الزمنية
لقاح ثنائي كبار (الخناق والكزاز Td)	كل عشر سنوات من عمر ٥٠ سنة
لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV13)	جرعة واحدة من عمر ٦٥ سنة
انفلونزا	سنوياً
لقاح السحايا الرباعي المقترن	جرعة واحدة كل خمسة سنوات
لقاح كوفيد ١٩	جرعة واحدة او جرعتين حسب الشركة المصنعة للقاح

العلاج الوقائي

تقييم الخطورة بالاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية واستعمال الاسبرين	ضمن حزمة الخدمات الرعاية المتكاملة للامراض غير الانتقالية

المشورة

التغذية . النشاط البدني . الوقاية من الامراض ، ترك التبغ والتدخين ، التعرض لاشعة الشمس . ترك الكحول ، الوقاية من السقوط . الابتعاد عن تناول الادوية بدون استشارة الطبيب	في كل زيارة

٢. السياقات العامة التي تؤخذ بالاعتبار حول اعطاء المشورة السريرية:-

ان المشورة السريرية يجب ان تكون موجهة لتحسين ممارسات الصحة والتي قد تكون ذات فائدة وقيمة اكبر للمريض من الاجراءات السريرية الاخرى .

ندرج فيما يلي الارشادات العامة التي تؤخذ بنظر الاعتبارعند تقديم المشورة السريرية :-

١- اعطاء المعلومات والخدمات بطريقة مناسبة وملائمة مع المحيط الثقافي ، القيم والتقاليد المجتمعية.

٢- استعمال مختلف الطرق والوسائل لتحسين ايصال المشورة

أ- استخدام عدة مصادر لتقوية التصرفات الصحية السليمة (استعمال بوسترات ، فولدرات والمواد الاخرى) .

ب- تقييم احتياجات المريض حول انماط الحياة الصحية ومدى التزام الكبير بها .

ت- فريق عمل يعطي المشورة (يتكون من : مسؤول تعزيز الصحة ،مسؤول الامراض غير الانتقالية، مسؤول التغذية ومسؤول التدخين) .

ث- اعادة وتكرار الرسائل الصحية لضمان ايصال المشورة.

٣- المشورة هي عملية موجهة لهدف معين لابد من تطبيق ميزات لاعطاء الفائدة للمتلقي توجههم لاستعمال المعلومات بطريقة تخدمهم للافضل في حياتهم .

٤- هناك١١ استراتيجية لمشورة المريض وتثقيفه:-

أ- تأطيرالتعليم ليتماشى مع استقبال المريض .

ب- تقديم المعلومات للمريض بشكل كامل حول الاهداف والتأثير المتوقع للتداخلات ومتى نتوقع التغييرات .

ت- نقترح تغييرات بسيطة وليست كبيرة .

ث- لنكن محددين

ج- احيانا يكون من الاسهل اضافة سلوك صحي جديد على التخلص من سلوك موجود.

ح- الربط بين السلوك الجديد بالسلوك القديم.
خ- استعمال سلطة المهنة بطريقة مراعية لشعور الكبار.
د- الحصول على التزام صريح من المريض .
ذ- استخدام اكثر من الاستراتيجية
ر- مشاركة منتسبي المكتب
ز- مراقبة التقدم من خلال زيارات المتابعة .

في كل مرة من المشورة السريرية ،لابد من مقدم الخدمة أن يساعد المريض بوضع هدف وخطة عمل قصيرة الأمد للوصول الى الهدف .

مثال لخطة العمل

1-ماذا ؟ (المشي , منع الطعام غير الصحي)

2- كم ؟ (مثلا المشي نص ساعة يوميا)

3- متى ؟ (بعد الغداء الاثنين , الاربعاء , الخميس)

4- كم مرة ؟ (خمس مرات بالاسبوع)

مثلا : هذا الاسبوع اقرر المشي خمس مرات بالاسبوع بعد الغداء لمدة نص ساعة يوميا

الثقة من 0 الى 10

وتقدر مدى تطبيق خطة العمل

٣. ادخال خدمات التحرر من التبغ ضمن الرعاية الصحية الاولية (المداخلات المبسطة للتحرر من التبغ 5A)

- تقديم خدمات الحماية من التبغ (3A)
- تقديم خدمات الاقلاع عن التدخين(2A)

الهدف من المداخلات المبسطة للتحرر من التبغ في مراكز الرعاية الصحية الاولية:

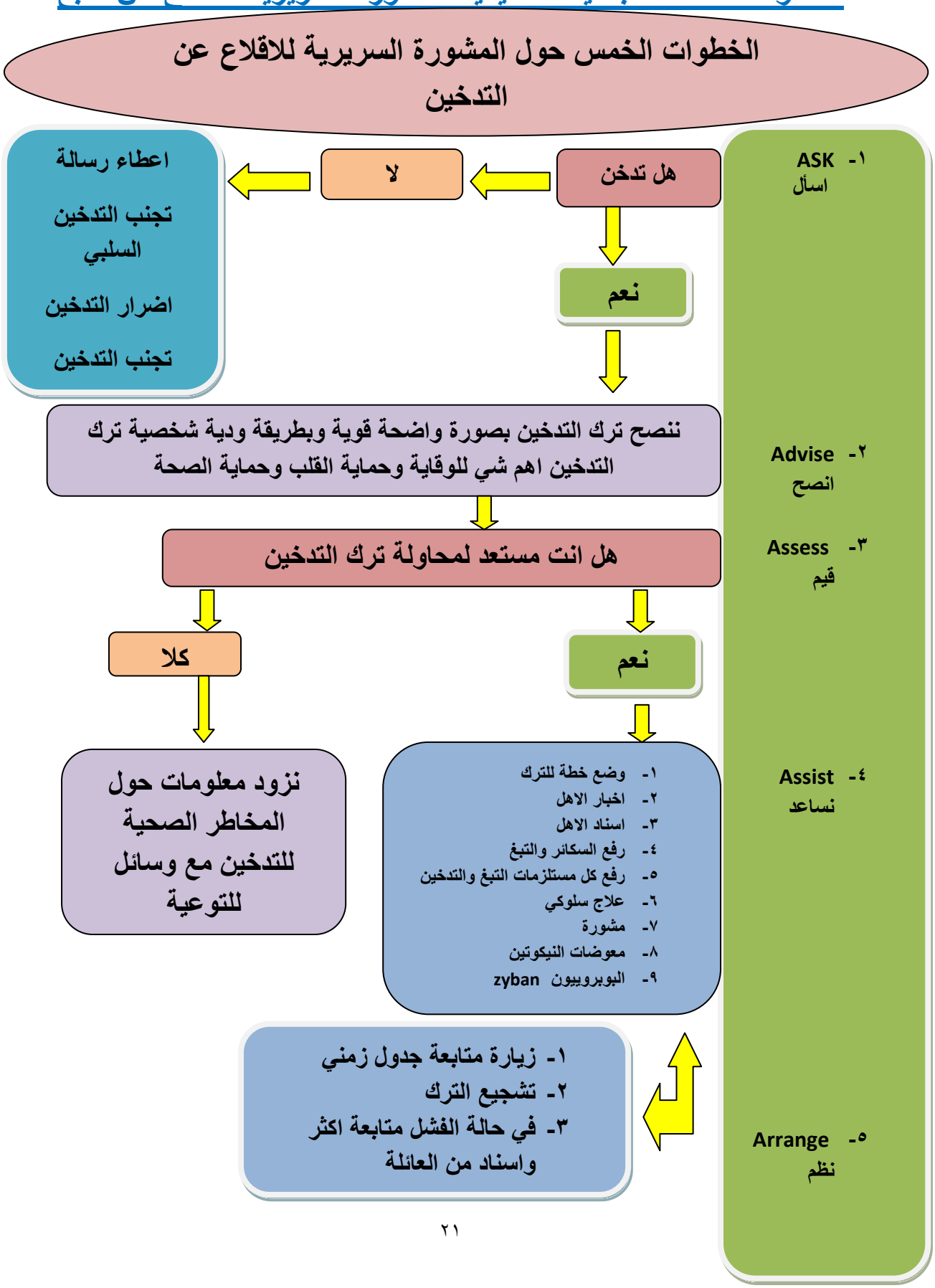
١. مساعدة المدخنين على الاقلاع عن التدخين
٢. منع غير المدخنين من الشوع بالتدخين
٣. الحفاظ على غير المدخنين من التعرض لدخان الاخرين.



خدمات الإقلاع عن التدخين (Assist & Arrange)

١. مناقشة اضرار التدخين الصحية (المباشرة وغير المباشرة) والبيئية والاقتصادية
٢. مليء استمارة المدخن مع حساب كمية النيكوتين التي يتعاطاها المدخن باليوم الواحد وتصنيف المدخنين بحسب درجة الادمان على التبغ.
٣. قياس نسبة اول اوكسيد الكاربون في الرئة بأستخدام جهاز ال co analyzer
٤. تقديم خدمات المشاورة والارشاد والدعم النفسي (العلاج السلوكي)
٥. وصف بدائل (معوضات) النيكوتين المناسبة والادوية الضرورية للمدخنين بحسب حاجة كل مدخن وبتوقيع طبيب الوحدة.
٦. تنظيم جدول زيارات (مراجعات) وفق جدول زمني محدد للمدخنين لغرض متابعتهم وتشجيعهم على الاستمرار بترك التدخين.

الخطوات الخمسة البنائية التنظيمية للمشورة السريرية للأقلاع عن التبغ



استمارة الاقلاع عن التدخين

الرقم التسلسلي																			
تاريخ تنظيم الاستمارة																			
الاسم الكامل																			
العمر																			
الجنس		ذكر																انثى	
الحالة الزوجية		اعزب			متزوج			مطلق			ارمل								
المهنة																			
التحصيل الدراسي		امي			يقرء ويكتب			ابتدائية			متوسطة وثانوية			دبلوم فما فوق					
محل السكن (العنوان الكامل)																			
طريقة الاحالة		طوعي			مستشفى			عيادة خاصة			مركز صحي			اخرى					
تاريخ البدء بالتدخين																			
فترة التدخين (بالسنين)																			
نوع التدخين		سكاير			اركيلة			سكار			اخرى								
الكمية		سيكارة/يوم			ساعة/يوم			سيكار/يوم											
بمن تاثرت عند بدء التدخين		الاهل			الاقارب			صديق			لااحد			اخرى					
التاريخ المرضي	.....																		
هل توجد محاولات سابقة لترك التدخين		نعم			لا			اذا نعم اذكر عدد المرات											
متى تدخن اول سكارة بعد الاستيقاظ مباشرة؟		بعد٦٠دقيقة (٠)			٦٠-٣١ (١)			٣٠-٦ (٢)			خلال ٥ دقائق (٣)								
هل تجد صعوبة في الامتناع عن التدخين في الاماكن المحظورة؟		نعم (١)						لا(٠)											
ما هي السيجارة التي يصعب عليك الامتناع عنها؟		أي سكارة (٠)						أول سكارة في الصباح (١)											
كم سكارة تدخن باليوم؟		١-١٠(٠)			٢٠-١١(١)			٣٠-٢١(٢)			٣٠+(٣)								
هل تدخن في الساعة الاولى من الصباح أكثر من بقية اليوم؟		نعم (١)						لا (٠)											
هل تدخن وانت مريض جداً وملازم للفراش؟		نعم (١)						لا (٠)											
التقدير النهائي لنسبة الادمان		١-٣ :ادمان قليل			٤-٥ :ادمان متوسط			٦-١٠ :ادمان عالي											
قياس نسبة اول اوكسيد الكاربون (PPM)																			
عقار البوبروبين (zyban)		تاريخ الاعطاء						الكمية والجرعة											
تاريخ ترك التدخين																			
المتابعة الاولى		التاريخ						قياس CO											
Patch																			
Lozenges																			
Gum																			

عقار النيوروبين (zyban)				
المتابعة الثانية	التاريخ		قياس CO	
Patch				
Lozenges				
Gum				
عقار النيوروبين (zyban)				
المتابعة الثالثة	التاريخ		قياس CO	
Patch				
Lozenges				
Gum				
عقار النيوروبين (zyban)				
المتابعة الرابعة	التاريخ		قياس CO	
Patch				
Lozenges				
Gum				
عقار النيوروبين (zyban)				
المتابعة الخامسة	التاريخ		قياس CO	
Patch				
Lozenges				
Gum				
عقار النيوروبين (zyban)				
المتابعة السادسة	التاريخ		قياس CO	
Patch				
Lozenges				
Gum				
عقار النيوروبين (zyban)				

المتابعة السابعة	التاريخ	قياس CO	النتيجة		
			مقلع		ملتكس
المتابعة الثامنة	التاريخ	قياس CO	النتيجة		
			مقلع		ملتكس
المتابعة التاسعة	التاريخ	قياس CO	النتيجة		
			مقلع		ملتكس
المتابعة العاشرة	التاريخ	قياس CO	النتيجة		
			مقلع		ملتكس

ملاحظات:

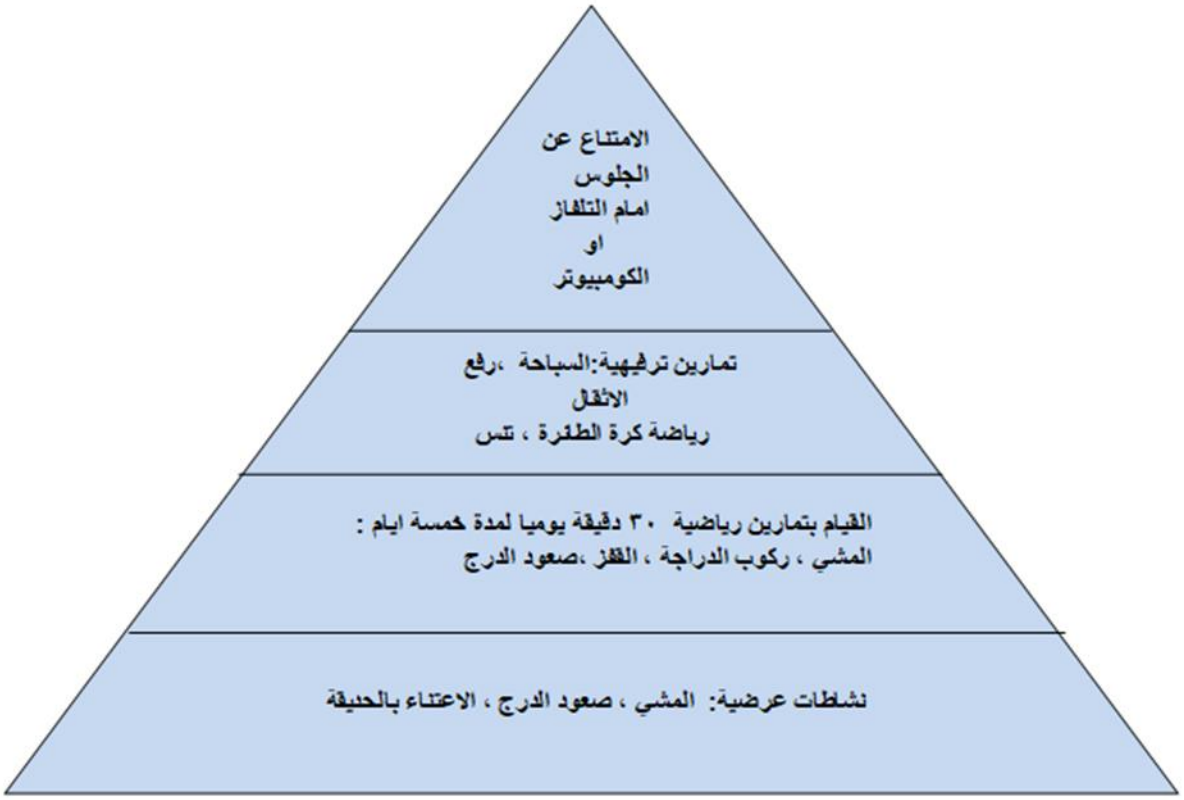
١. تاريخ المتابعة الأولى بعد سبعة أيام من تاريخ الزيارة الاولى
٢. الفترة الزمنية بين متابعة واخرى اسبوعين
٣. المتابعة السابعة تكون بعد شهر من المتابعة السادسة
٤. المتابعة الثامنة تكون بعد شهرين من المتابعة السابعة
٥. المتابعة التاسعة تكون بعد ثلاثة اشهر من المتابعة الثامنة
٦. المتابعة العاشرة تكون بعد ستة اشهر من المتابعة التاسعة

٤. المشورة حول النشاط البدني

أ- التأكد مما يلي:

- تقييم الكبير حول مدى ممارسته للنشاط البدني بممارسة الانشطة العامة ، المهنية والعملية، والأنشطة النظامية .
- معرفة هل أن النشاط كافي وحسب هرم النشاط البدني اذ ان النشاط المتوسط الشدة لمدة نصف ساعة يوميا لمدة خمسة ايام في الاسبوع كافي للصحة .
- النشاط المتوسط الشدة يسبب تسارع النبض ،تسارع التنفس مع الشعور بالحر.

كما هو موضح في هرم النشاط البدني



هرم النشاط البدني

ب- مساندة الكبير أو المريض الذي يفتقر لفعاليات النشاط البدني المختلفة بوضع خطة لبرنامج للنشاط البدني الذي يجب ان يراعي مايلي :

١- آمن طبيا : المصابين بامراض القلب والاوعية الدموية يجب ان يجرى التقييم الصحي قبل الشروع بأي برنامج للنشاط البدني الشديد للاشخاص :

- المصاب بامراض القلب والاوعية الدموية
- الرجل فوق ٤٠ من العمر والانثى فوق ٥٠ الذين لديهم عوامل خطورة للاصابة بامراض القلب كارتفاع الدهون ، ارتفاع ضغط الدم والمدخنين

٢- اعطاء نصائح لتعزيز النشاط البدني الآمن طبياً ويشمل:

- البدء تدريجيا بالنشاط البدني
- تقليل خطر الإصابة بالجهاز العضلي العظمي بجعل التمارين بين يوم واخر واستعمال تمارين التمدد في الاحماء والتبريد في جلسات التمارين خاصة للكبار الذين لم يكونوا نشيطين في الفترة الماضية

٣- ممتع: لكي ينجح البرنامج لابد ان يكون ممتع وغير ممل وذلك عن طريق

- مع الاقارب والاصدقاء
- تمارين متنوعة وغير مكررة

٤- مناسب تشجيع المشاركة الممتعة بدون تحضيرات مسبقة

- واقعي: اختيار البرنامج الصعب سيؤدي الى الملل
- منظم: وضع خطة وأهداف يؤدي إلى الالتزام ونجاح البرنامج

لابد من تحديد المعوقات للتمتع وحسب الجدول التالي :

المعوق	الاستجابة والحلول
التمارين عمل متعب	البدء بالمشي العادي
ليس لدي الوقت	قد يكون صحيح ولكن لاتستطيع الجزم الا اذا جربت ذلك
أنا تعبان جدا للتمارين	أخبر نفسك أن التمارين ستعطيني طاقة وتحسن من صحتي
أخشى من الفشل ولهذا لن ابدأ	لن تفشل اذا قمت بأختيار التمارين التي تحب تدريجيا مع وضع اهداف واقعية
ليس لدي أحد ليشاركني ذلك	قد يوجد صديق أو جار أو قد تجد التمارين التي تريد أن تمارسها وحدك
لايوجد المكان المناسب	أمشي حول منطقتك أو مول أو تستطيع عمل التمارين مع العرض التلفزوني او عرض الكومبيوتر
أخاف أن أتعرض للشدة أو للسقوط	المشي آمن جدا بأختيار الاماكن الأمنة
الجو غير جيد	تستطيع عمل النشاط في البيت أو المول
التمارين مملة	تستطيع الاستماع الى الموسيقى او مشاركة صديق او اعطاء جائزة بعد الوصول الى الهدف
أنا لدي سمنة	اختيار التمرين مهم.. المشي مثلا ليس لديه علاقة بالسمنة
عمري كبير	دائما هناك الوقت. .اي شخص وخاصة الكبير يحتاج النشاط البدني للصحة

جـ-

تشجيع الشخص الذي ليس لديه الرغبة بالمشاركة في التمارين الرياضية عن طريق ايجاد البدائل: استعمال الدرج بدل عن المصاعد، النزول مبكرا من الباص للوصول الى المكان مشيا ، القيام بالاعمال المنزلية .

د-

توفير ملاك تمريضي لمراقبة التقدم الذي يحرزه الكبير في مزاولة النشاط البدني .

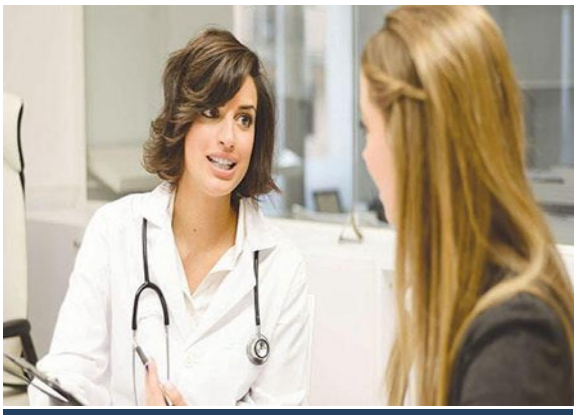
ه-

اعداد الفولدرات ومواد التوعية حول اهمية النشاط البدني .

و-

مشاركة مقدمي الخدمة في النشاطات الرياضية.





٥. اساسيات المشورة عن التغذية

- قياس الوزن
- التحدث مع الكبير عن العادات الغذائية والمكملات الغذائية
- اعطاء معلومات اساسية عن الغذاء الصحي
- التوعية واستعمال دليل العمل التغذوي



دليل العمل التغذوي

- تناول طعام متنوع
- التوازن بين الطعام والنشاط البدني للحفاظ على الوزن
- اختيار طعام غني بالالياف كالفواكه والخضروات
- اختيار طعام قليل الدهون
- اختيار طعام معتدل السكريات
- اختيار طعام معتدل في الملح

الحصص الغذائية

- ٨حصص (اكواب) ماء
- ٦ حصص من الحبوب والنشويات(معكرونة ،رز، خبز،برغل.....)على ان تكون نصف الكمية من الحبوب الكاملة.
  تعادل الحصة الواحدة ربع من الصمون او الخبز او نصف كوب من الحبوب المطبوخة كالرز والبرغل...
- ٢-٣ فواكه و٣خضروات(الخضراوات الخضراء الداكنة،الخضراوات البرتقالية ،الخضراوات الحمراء والخضراوات النشوية) تعادل الحصة الواحدة نصف كوب من الخضراوات المطبوخة او كوب واحد من الخضراوات الورقية الطازجة
- ٢-٣ حصص من اللحوم (سمك، اللحم الاحمر بدون دهون، لحم الدجاج منزوع الجلد والبقوليات والبيض)
  تعادل الحصة الواحدة ٣٠غرام من اللحوم بانواعها او بيضة واحدة او ربع كوب من البقوليات المطبوخة
- ٣ حصص من الحليب ومشتقاته قليلة الدسم تعادل الحصة الواحدة كوب واحد من الحليب او اللبن او ٦٠ غرام من الجبن المطبوخ
- كمية قليلة من المكسرات المتنوعة .

- مراعاة شروط السلامة الغذائية وتناول الطعام الصحي الامن.
- الحرص على تناول الطعام الغني بالمغذيات الدقيقة مثل فيتامين١٢B,,A,D وغيرها وفي حال الاحتياج لها فيتم اعطاءها كمكملات غذائية.
- للنساء اعطاء المشورة الخاصة بتناول كميات كافية من الاغذية الغنية بالكالسيوم كمنتجات الالبان ، السمك ، الحبوب ، البروكلي والسبانخ الاحتياج اليومي ١٥٠٠ ملغم
- للمصابين بالسمنة نوصي باخذ غذاء قليل الدهون والسعرات بالاضافة الى النشاط البدني .
- الاسناد ودعم الاشخاص الذي لديهم نظام غذائي عن طريق المتابعة
- احالة الذين لديهم مشاكل غذائية.

رابعــاً المشاكل العملاقة في مرحلة الشيخوخة

الكبار لديهم غالبا امراض متعددة مصاحبة لحالات اجتماعية مختلفة وقد تكون الشكوى الرئيسية لهم غير واضحة وصعبة ، هذه الاعراض المرضية المختلفة من الصعب التعامل معها في المركز الصحي معظمها مزمن وتحتاج الى غربلة وكشف مبكر ومعالجة سريعة ومستمرة منعا لحدوث المضاعفات التي قد تسبب الاعاقة، من الصعب معالجة جميع الحالات المرضية ولكن ممكن التركيز على المشاكل العملاقة لكبار السن والتي تشمل :

١- فقدان الذاكرة
٢- سلس البول
٣- الاكتئاب
٤- السقوط / عدم الحركة

بالاضافة الى ارتفاع ضغط الدم والسكري .

الهدف العام:- تدريب العاملين الصحيين لاستعمال ادوات تقييم الاصابة بالمشاكل العملاقة الاربعة والامراض الرئيسية الاثنان للكبار .

من يستعمل الاداة او الاستمارة ؟

كل استمارة او اداة موضح فيها من يستعمل هذه الاداة

١- الفحص الشامل (استمارة الفحص الشامل)

٢- التقييم السريري والتقارب العلاجي للمشاكل العملاقة لكبار السن

٣- تقييم سريري وعلاجي للامراض المزمنة : ارتفاع ضغط الدم والسكري

نقاط الكفاءة الاساسية ومدى توفرها في مقدمي الخدمة لكبار السن والتي تعتبر كقائمة اختبار للاحتياجات التدريبية للعاملين الصحيين .

التواصل:- (اداة الاتصال)

١- اظهار المهارات والمعارف الضرورية للاتصال والتعامل مع الكبار .
٢- تشجيع المشاركة في القرارات .
٣- تقييم الحواجز الموضوعة للكبار (فهم المعلومات) .

٤- توفير الحماية الصحية ،تعزيز الصحة ،والمعلومات الوقائية .

٥- شمول مقدم الخدمة في العائلة في الفعاليات التدريبية .

المعارف:-

١-اظهار المعارف وفهم التغيرات التي تصاحب التقدم في العمر وما هي احتياجاتها .
٢-اظهار الاهتمام والوعي حول التغيرات الحسية التي تصاحب الشيخوخة .
٣-اظهار معارف الكبار (الاعراض غير المألوفة) .

تقييم الحالة الصحية:-

١- يجب ان يكون هنالك علاقة بين المرض الحاد والمرض المزمن .
٢- تقييم الصحة او المرض من خلال التاريخ المرضي .
٣- فحص الكبير فحص مفصل آخذين بنظر الاعتبار التغييرات مع التقدم في السن .
٤- عمل تقييم وظائفي شامل (الحالة العقلية،الاسناد الاجتماعي ،والتغذية) .
٥- تقييم المهام والاجهاد لمقدمي الرعاية للكبير .

التشخيص والعلاج:-

١- تحديد الحالات الشائعة مع كبار السن .
٢- تطبيق الغربلة للكبير .
٣- وضع وقت للتداخل المناسب اعتماداً على التقييم .
٤- اظهار تفهم حول الادوية المناسبة للكبار وخاصة الامتثال لاستعمال الدواء
٥- وضع خطة للتداخلات العلاجية للحفاظ على الحد الادنى من الاداء الوظيفي.
٦- التناسق بين الرعاية والخدمات المتوفرة الصحية والاجتماعية الاخرى .

المركز ودي لكبار السن

Kerbalaa NCD

الأولوية لكبار السن للدخول الى الطبيب



١- الفحص الشامل (استمارة الفحص الشامل)

الجزء الاول

يمكن تطبيقه من قبل ملاك صحي متدرب

التاريخ:

الاسم:_____ العمر:_____

الجنس: ذكر:_____ انثى: _____

العلامات الحيوية:

قياس الضغط: _____ النبض:_____

درجة الحرارة:_____

الوزن:_____ الطول:_____مؤشر كتلة الجسم:_____

التاريخ الاجتماعي:

الحالة الاجتماعية:_____ مع من تسكن؟_____

اللغة المحلية:_____

هل لديك اولاد؟ نعم كلا

كم مرة تراهم في الاسبوع ؟ _____

من يقوم بمساعدتك؟_____

هل مساعدته كافية؟ نعم كلا

نوع السكن ؟ بيت شقة

هل تستخدم السلم ؟ نعم كلا

التاريخ العائلي

ضغط _____ سكري _____ خرف _____

امراض القلب _____ اخرى _____

التاريخ المرضي السابق

☐ الضغط ☐ امراض القلب والاوعية الدموية ☐ الكوليسترول

☐ الجلطة الدماغية ☐ امراض الاوعية الدموية الطرفية

☐ امراض الغدة الدرقية

☐ السكري ☐ امراض الاعصاب المحيطية

☐ السمع ☐ البصر

☐ الشلل الرعاشي(باركنسون) ☐ الصرع ☐ الكحول

☐ اكتأب ☐ التهاب الكبد ☐ السرطان

☐ اصابات الرأس

الجزء الثاني

PART 2 – Examination TO BE DONE BY DOCTOR

Eyes □ normal conjunctiva & lids

Pupil's □ pupils symmetrical, reactive

ENT External ear □no scars, lesions, masses

Otoscopic □normal canals & tympanic membranes

Oral □ normal lips, teeth, gums

Oropharynx □ normal tongue, palate

Neck palpation □ Symmetrical without masses

Thyroid □no enlargement or tenderness

Respiratory

Respiratory rate: _____per min

Chest percusses. □ No dullness or hyper resonance

Auscultation □ normal bilateral breath sounds without rales

Cardiovascular

Heart palpation □ Normal location, size

Cardiac auscultation □no murmur

Carotids □ normal intensity without bruit

Pedal pulses □ normal posterior tibia & dorsalis pedis

Breasts □normal inspection & palpation

Abdomen □no masses or tenderness

Liver/Spleen □normal liver/spleen

Hernia □no hernia identified

Genitourinary male □external genitalia normal without lesions

Genitourinary female

inspection □ normal external genitalia

PV examination

vagina and Cervix □ normal appearance without discharge

Uterus □ normal size, position, without tenderness

Adnexa □no masses or tenderness

Additional description of positive findings (including behavioral changes)

---.

Recommendations/plan:

□Diagnosis

□ Investigations

□Lab
□Electrolytes □Ca □TSH □D3 □others

□ Imaging (type, date)_____

□Last EKG: date_____ Description_____
□Management

Treatment :-

Referrals :-

Follow-up:-

٢- التقييم السريري والعلاجي للمشاكل العملاقة لكبار السن

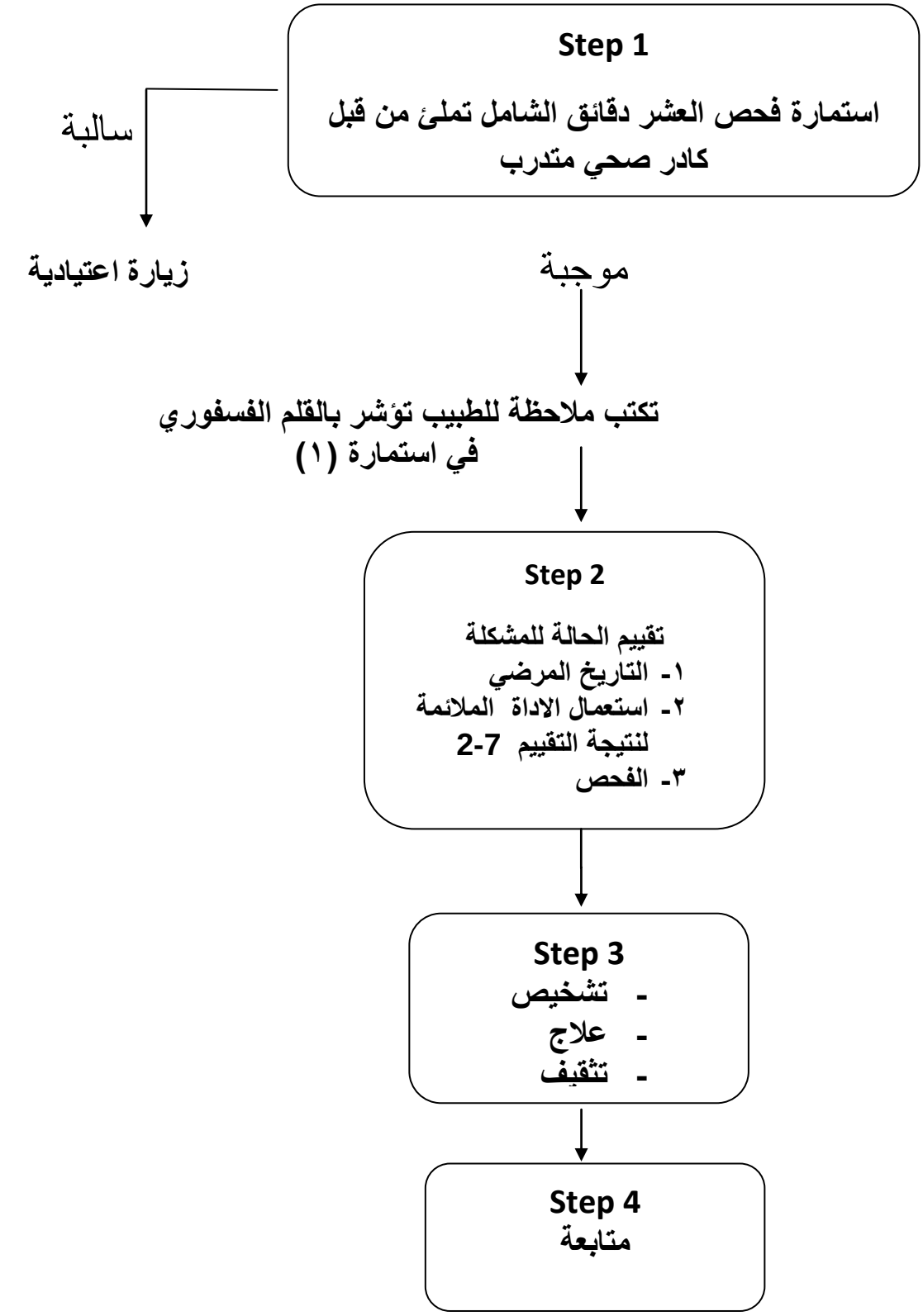
لغرض معرفة وتقييم المشاكل الصحية التي يعاني منها كبار السن الذين يراجعون مركز الرعاية الصحية الاولية كما موضح في **مخطط معالجة المشاكل الصحية للكبار في المراكز الصحية** الذي يطبق سنوياً لجميع المرضى من عمر ٦٠ سنة فأكثر(او حسب راي الطبيب)

- الخطوة الاولى فحص العشرة دقائق الشامل (اداة ١) يغربل من قبل ملاك صحي مجتمعي متدرب
- اذا كانت نتيجة الغربلة (ايجابية)لأي مشكلة تتبع الخطوات (الخطوة ٢،الخطوة٣،الخطوة٤)
- اذا مشكلة تغذوية ← يحال الى الطبيب
- اذا مشكلة في السمع والبصر ← يحال الى الطبيب



مخطط لمعالجة المشاكل الصحية للكبار في المراكز الصحية

تطبق سنوياً لجميع المرضى من عمر ٦٠ سنة فأكثر(او حسب راي الطبيب)



الاداة ١: (tool 1) فحص العشرة دقائق الشامل

الغاية منه	لغربلة المشاكل الصحية الرئيسية للكبار
يتم بواسطة	ممرض، ملاك صحي مدرب
كم يستغرق	١٠ دقائق

اولاً/ الذاكرة

اعطي التعليمات التالية لكبير السن " سأقوم بتسمية ٣ اشياء **(قلم ، شاحنة، كتاب)** سوف اطلب منك ان تعيدها الان وبعد دقيقة من الان.....رجاءً حاول ان تتذكرها"

سجل ذلك بعد سؤال القدرات البدنية الوظيفية (الفقرة رابعاً)

ثانياً/ السلس البولي

١-اسأل " خلال السنة الماضية .. هل فقدت السيطرة على الادرار ولو لمرة واحدة؟

نعم_____ كلا _____

اذا كان الجواب كلا انتقل الى ثالثاً

اذا كانت الاجابة نعم أسال السؤال الثاني

٢-"هل فقدت السيطرة على الادرار في الاسبوع الماضي؟

نعم _____ كلا_____

اذا كان الجواب نعم **للسؤالين** يحال الى " التقييم السريري للسلس البولي" **ص ٤٩**

ثالثاً / الاكتئاب

اسأل " هل تشعر احياناً كثيرة بالحزن او الاكتئاب؟

نعم _____ كلا _____

اذا كان الجواب نعم يحال الى " التقييم السريري للاكتئاب" **ص ٤٧**

رابعاً / القدرات البدنية الوظيفية

اسأل " هل انت قادر على

١- الركض/ المشي السريع للحاق بالحافلة؟ نعم _____كلا _____

٢-اداء الاعمال المنزلية الثقيلة مثل غسل الشبابيك والجدران والارض؟ نعم___ كلا ___

٣-التسوق من البقالة او شراء الملابس؟ نعم _____ كلا _____

٤- الذهاب الى اماكن خارج منطقة السكن بأستخدام سيارة او حافلة) ؟نعم _____كلا_____

- الاستحمام وقوفاً او باستخدام حوض الاستحمام؟ نعم _____ كلا _____

٦-ارتداء الملابس ، مثل ارتداء القميص ،غلق الازرار او ارتداء الاحذية؟نعم_____كلا_____

يعتبر التقييم ايجابي (لكل سؤال) اذا كان المريض غير قادر او قادر بمساعدة او اشراف شخص اخر

اذا كان التقييم ايجابي يحال الى الطبيب

هل اكمل المريض استذكار الاشياء الثلاثة التي تم تسميتها مسبقاً

اسأل عن هذه الاشياء الثلاثة:

١)_____ ٢)_____ ٣)_____

هل تم تسمية الاشياء الثلاثة ؟ نعم _____ كلا _____

اذا كان الجواب كلا يحال الى " التقييم السريري لفقدان الذاكرة" **ص ٤٢**

خامساً/ السقوط

١-هل تعرضت للسقوط مرتين او اكثر خلال ال ١٢ شهرا الماضية

نعم _____ كلا _____

اذا كان الجواب كلا .. فقم بما يأتي:

٢- اعط التعليمات التالية " اقم من على الكرسي ، در حوله بدون ان تمسك بشيء"

غير قادر على ذلك نعم_____ كلا _____

غير متزن نعم _____ كلا _____

اذا كان الجواب نعم لسؤال واحد على الاقل يحال الى " التقييم السريري للسقوط" **ص ٥٢**

سادساً/ المشاكل الشائعة الاخرى

التغذية

تاريخ تسجيل الوزن ___/_____/_____ الوزن _____ كغم

١-هل لاحظت تغيراً في وزنك خلال ال ٦ شهور الماضية؟ نعم _____ كلا _____

في حال تم تسجيل الوزن في الزيارة السابق

مقدار الزيادة _____ كغم او مقدار النقصان _____ كغم

اذا تم ملاحظة مشكلة في الوزن يحال الى اساسيات المشورة عن التغذية **(ص ٢٨)**

السمع

قف خلف المريض وردد **بصوت منخفض** الارقام التالية **(٩،١،٦)** واطلب منه ان يردد بعدك

هل يسمع الصوت المنخفض؟ الاذن اليمنى نعم ____ كلا____

الاذن اليسرى نعم ____ كلا____

الان ردد نفس الارقام **بصوت عادي** واطلب منه ان يردد بعدك

هل يسمع الصوت العادي؟ الاذن اليمنى نعم ____ كلا____

الاذن اليسرى نعم____ كلا____

التقييم ايجابي عندما لا يستطيع السمع بأذنين او أذن واحدة (او اي اجابتين بكلا مجتمعة)

اذا وجدت مشكلة ، يتم اعلام الطبيب لجراء اللازم.

الرؤية

١-اسأل " هل تواجه صعوبة بالقراءة او اداء النشاطات اليومية بسبب الرؤية ؟"

(حتى مع ارتداء النظارات)

نعم____ كلا____

التقييم الايجابي : نعم

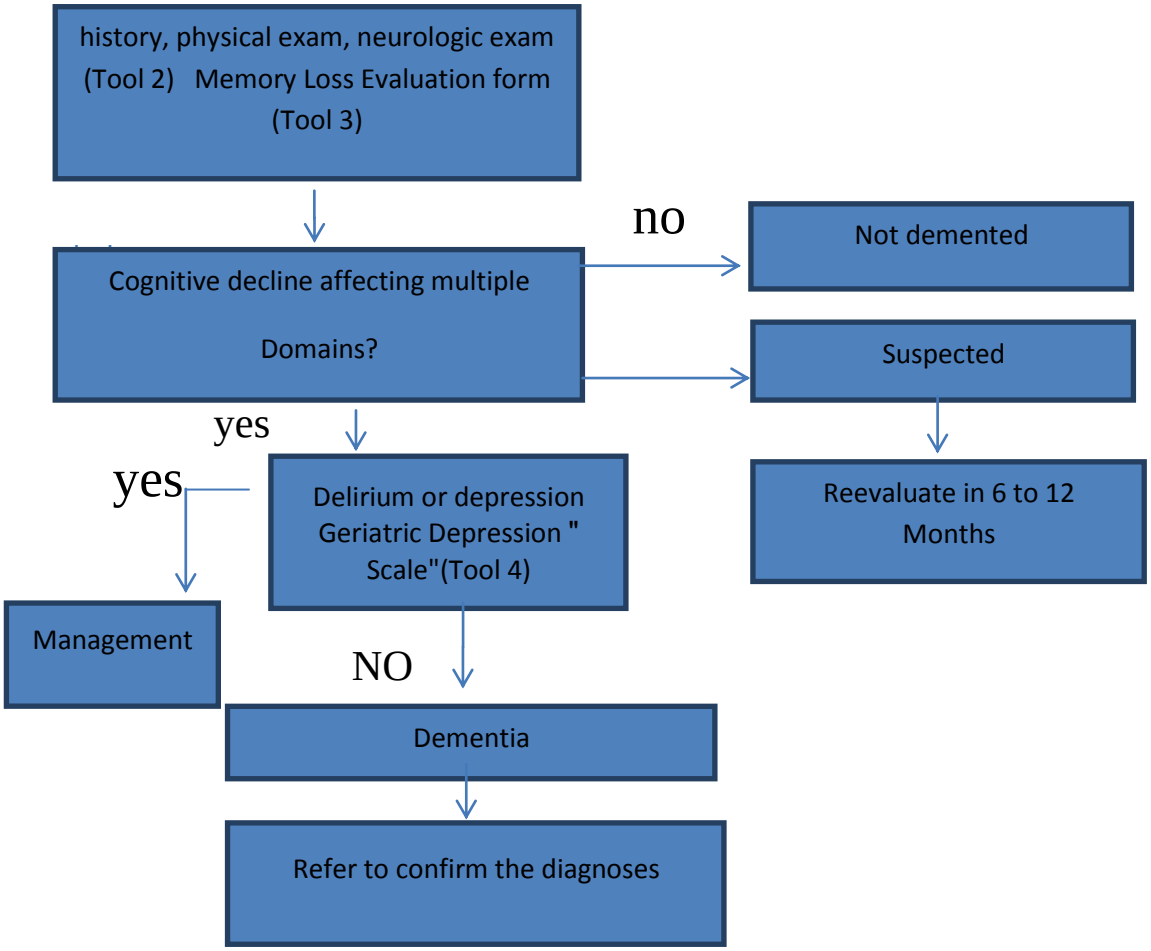
٢- اذا كان التقييم ايجابي ،اطلب اكمال فحص سنيلين Snellen اذا توفر

(بدون نضارات اولاً ثم مع النضارات)

درجة العين اليمنى _____ درجة العين اليسرى _____

1.Memory loss

Managing memory loss If positive on screening tool



Tool 2-: Mini-mental state examination (MMSE)

What for?	Screening of cognitive impairments
By whom?	Medical doctor
How long?	15 minutes

Tool 2 MMSE

NAME OF SUBJECT _____ Age_____

Years of School Completed ____ _____

Approach the patient with respect and encouragement.

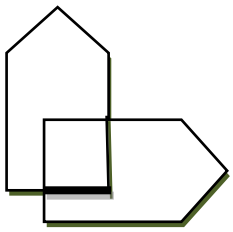
Date of examination ----------

Ask: Do you have any trouble with your memory? Yes [ ] No [ ]

May I ask you some questions about your memory? Yes [ ] No [ ]

ITEM	SCORE
Time orientation Ask : What is the year ? 1 Season ------1 Month of the year ? 1 Date ---------1 Day of the week -------1	5
Place orientation Ask : Where are we now؟ What is the state----------1 city ----------1 part of the city ----------1 building----------1 floor of the building---------- 1	5

Registration of 3 words Say : listen carefully . I am going to say 3 words You say them back after I stop. Ready? Here they are...**apple**..(wait one second)..**table**..(wait one second)..**pen**..(wait one second) What were those words? _____(1 _____(1 _____(1 Give 1 point for each correct answer, then repeat them until the patient learns all three	3
SERIAL 7 as a test for attention & calculation: Ask: Subtract 7 from 100 and continue to subtract 7 from each subsequent remainder until I tell you to stop . What Is 100 take away 7 ? ------- Say: Keep Going _____(1), _____(1) _____(1), _____(1), _____(1)	5
Naming: Ask: What is this? (show pencil)_____(1), What is this? (show watch)_____(1)	2
Repetition: Say: Now I am going to ask you to repeat what I say. Ready? "No ifs, ands, or buts" "بلا إذا ولا لكن ولا أو" Now you say that. _____(1)	1
Comprehension : Say: Listen carefully because I am going to ask you to do something: Take this paper in your left hand (1), fold it in half (1), and put it on the floor. (1)	3
Reading: Say: Please read the following and do what it says, but do not say it aloud. (1) **"Close your eye"**	1

writing : Say: Please write a sentence. If patient does not respond Say: Write about the weather. (1)	1
Drawing : Say: Please copy this design. 	1

SCORE:-

27-30	**Normal**
20-26	**Mild impairment**
10-19	**Moderate impairment**
Below	**Severe impairment**
For scores below 27	**Complete the memory loss evaluation form(Tool 3) and follow the flowchart for managing memory loss**

Tool 3: Memory loss evaluation form

What for?	Memory loss clinical questioning
By whom?	? Medical doctor
How long?	5-15 minutes

Name: ---------- Age: ---------- Date: ---------- ---------

History of the memory problem

Psychiatric history

Family History

☐ Hypertension ☐ Dementia

☐ stroke ☐ Parkinson s disease

☐ Diabetes ☐ cardiovascular disease

☐ Depression ☐ Down ’s syndrome

Medications currently taking

Symptoms (circle positives)

☐ Speech difficulty ☐ confusion ☐ aggressive

☐ Delusions ☐ hallucinations

☐ Emotional change ☐ fall, injury

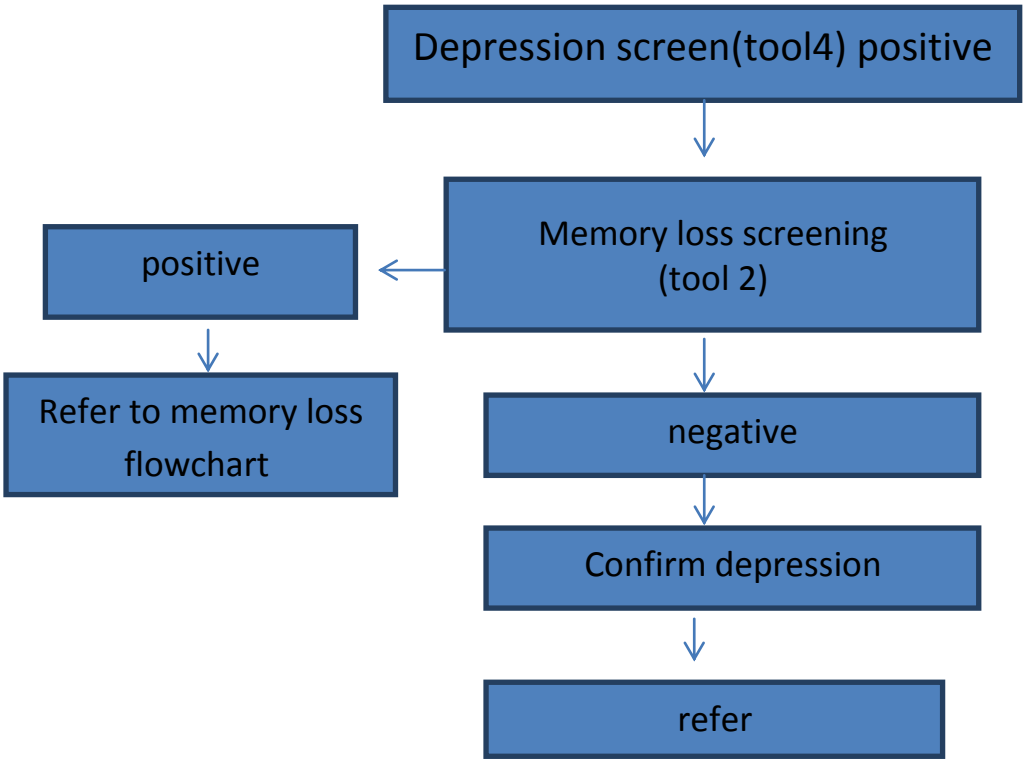
☐ Balance problems ☐ behavior changes

Main problem identified by family/caregiver

2. DEPRESSION

For persons without mental impairment:

Managing depression if screening tool indicates positive for depression (nurse does screening tool)



الاداة ٤ (tool 4) مقياس الاكتئاب لدى المسنين

الغاية منه	**قياس حالة الاكتئاب**
يتم بواسطة	**المريض، الممرض، ملاك صحي مدرب**
كم يستغرق	**٥ دقائق**

التعليمات :	إختر الجواب الأنسب لحالتك النفسية خلال الأسبوع الماضي		
١-	هل أنت بشكلٍ عام راضٍ عن حياتك ؟	نعم	**كلا (١)**
٢-	هل تخلّيت عن العديد من نشاطاتك و إهتماماتك ؟	**نعم (١)**	كلا
٣-	هل تشعرُ أنّ حياتك فارغة ؟	**نعم (١)**	كلا
٤-	هل تصاب بالملل عادة" ؟	**نعم (١)**	كلا
٥-	هل أنت في مزاجٍ حسن في أغلبية الوقت ؟	نعم	**كلا (١)**
٦-	هل تخاف أن يصيبك مكروه ؟	**نعم (١)**	كلا
٧-	هل تشعرُ بالسعادة أغلبية الوقت ؟	نعم	**كلا (١)**
٨-	هل تشعرُ عادة" أنّك بحاجة إلى مساعدة ؟	**نعم (١)**	كلا
٩-	هل تفضّل البقاء في غرفتك على الخروج و القيام بنشاطاتٍ جديدة ؟	**نعم (١)**	كلا
١٠-	هل تشعرُ أنّ مشاكل الذاكرة تصيبك أكثر من غيرك ؟	**نعم (١)**	كلا
١١-	هل تعتقد أنّه لأمرٌ رائع بقاؤك حيا" الآن ؟	نعم	**كلا (١)**
١٢-	هل تشعرُ أنّك لا تجدي نفعا" في الوقت الحالي ؟	**نعم (١)**	كلا
١٣-	هل تشعرُ أنّك شديد النشاط ؟	نعم	**كلا (١)**
١٤-	هل تعتقد أنّ وضعك ميؤوس منه ؟	**نعم (١)**	كلا
١٥-	هل تعتقد أنّ أغلبية النّاس بوضعٍ أفضل من الّذي أنت عليه ؟	**نعم (١)**	كلا
	مجموع النقاط (تسجل نقطة واحدة لكل اجابة بالخط العريض)		

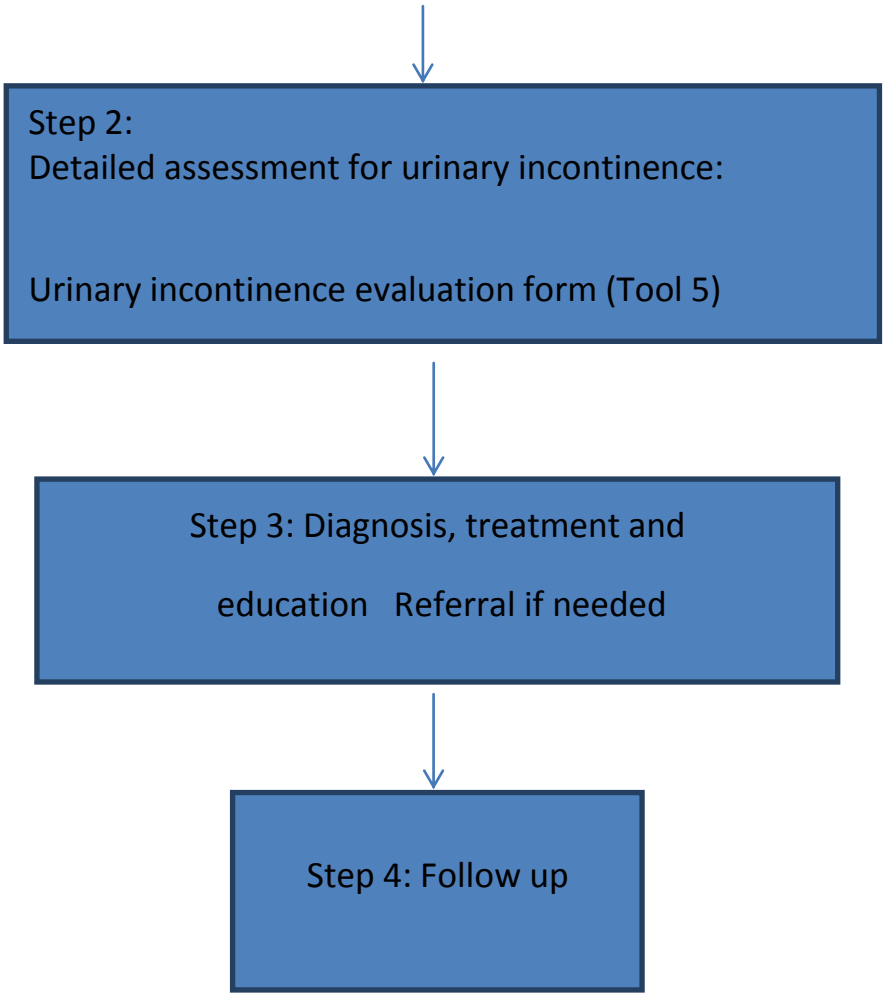
اذا كان مجموع النقاط أكثر من ٥ ، فأن المسن قد يكون مصاب بالاكتئاب ويحال الى الطبيب

3.URINARY INCONTINENCE

Clinical process of managing urinary incontinence

– **When risk of urinary incontinence is found**

If positive screening for urinary incontinence (Step 1)



الاداة ٥ (tool 5) تقييم السلس البولي

الغاية منه	**تقييم سلس البول**
يتم بواسطة	**الجزء الاول : ممرض أو ملاك صحي مدرب** **الجزء الثاني: طبيب**
كم يستغرق	**١٥ دقيقة**

الجزء الأول

الاسم: ---------- العمر:----------تاريخ ----------

تاريخ المرضى للجهاز البولي والتناسلي:

□سرطان المثانة □التهابات المجاري البولية □حصى الكلى □ تضخم البروستات للرجال

للنساء فقط:

عدد الاحمال السابقة ----------

انقطاع الطمث؟ نعم □ عدد سنوات انقطاع الطمث ----------

كلا □

علاج هرمون الاستروجين نعم □ كلا □

□ عملية إزالة الرحم □ عملية ازالة المبيضين □ تاريخ عائلي لسرطان الثدي

موجز سلس البول:

١- متى بدأت المشكلة؟

هل يؤثر ذلك على نشاطاتك اليومية؟ نعم □ كلا □

إذا كان الجواب نعم، كيف؟ ----------

٢- ما الذي يجعل المشكلة أسوأ؟

□ الركض □ العطاس □ السعال □ الضحك

□ حمل الاثقال □ الانحناء للاسفل □ سماع صوت الماء الجاري

٣- ما هي المشاكل التي تواجهها عند التبول في الحمام؟

□ مشكلة في بداية التبول

مشكلة تدفق البول بطيء

□ مشكلة عدم الراحة اثناء التبول

□ مشكلة الادرار الدموي

□ مشكلة افراغ غير كامل للمثانة

٤- مشاكل أفراغ المثانة

□يعاني من بلل بدون ان يشعر

هل تستطيع السيطرة (تحبس)على الادرار؟ □ سيطرة تامة في جميع الاوقات □دقيقة او دقيقتين

□عدة دقائق □ التبول الليلي الغير ارادي

PART 2(by doctor)

- Medication review – What medication are you currently taking? (Note beta blocker, sedative, narcotic, diuretic, anticholinergic, calcium channel blockers, non-prescription drugs, cold remedy, and herbals)
- **Treatment (as indicated)**

4.FALLS

The clinical process of managing falls
(When risk of falls is found)

If positive screening for falls (Step 1)

↓

Step 2:

Detailed assessment for falls:

- Falls evaluation Form (Tool 6)

- Analysis of gait/feet

- Activities of daily living assessment (Tool 7)

↓

Step 3: Diagnosis, treatment and education

↓

Step 4: Follow-up

Advise patient to

• seek medical treatment after fall,

• record falls,

• refer for home assessment/modification, help/assistance if needed/available

الاداة ٦ (tool6) تقييم السقوط

الغاية منه	**تقييم السقوط**
يتم بواسطة	**الجزء الاول : ممرض أو ملاك رعاية صحية مدرب** **الجزء الثاني: طبيب**
كم يستغرق	**٢٠ دقيقة**

الجزء الأول

الاسم :---------- العمر:----- التاريخ :----------

تاريخ التعرض للسقوط

لغرض وصف السقوط نحن بحاجة لسماع تفاصيل مشكلة السقوط الخاص بك حتى نتمكن من معرفة الاسباب. أجب على الأسئلة التالية عن اخرسقوط تعرضت له.

١- متى تعرضت للسقوط ؟ ----------
٢- التاريخ (تقريبي)---------- في اي قت من اليوم----------
٣- ماذا كنت تفعل قبل أن تسقط؟ ----------
٤- هل تتذكر سقوطك، أم أن أحدهم أخبرك عنه؟----------
٥- كيف كان شعورك قبل ان تسقط؟----------
٦- كيف كان شعورك وأنت تسقط؟----------
٧- على أي جزء من جسمك سقطت؟ ----------
٨- على ماذا سقطت؟----------
٩- هل ادى السقوط الى حدوث جروح؟----------
١٠- هل تتذكر أي شيء آخر اثناء السقوط؟----------
١١- هل تعتقد أنك أغمي عليك اثناء السقوط؟ ----------
١٢- هل لديك ألم في المفاصل؟ ----------
١٣- هل لديك عدم استقرار(ضعف) في المفاصل؟----------
١٤- هل لديك مشاكل في القدم ؟ ----------
١٥- هل تستخدم العصا او حجلة اثناء المشي؟----------

كم مرة سقطت في الأشهر الستة الماضية؟

PART 2(by doctor)

What medication are you currently taking?

☐Psychotropic medications ☐Diuretics ☐Antiarrhythmic
Noticed any vision changes ☐Yes/ ☐ Non
Eye exam past year ☐ Yes/☐ Non

Feet – any abnormalities
Gait analysis
Gait: normal abnormal
Up-and-Go test: ____sec

(patient who takes more than 30 seconds Is at risk)

Abnormal if: Hesitant start

☐Broad-based gait
☐Extended arms
☐Heels do not clear toes of other foot
☐Heels do not clear floor
☐Path deviates

Up-and-Go test:
-Stand from chair,
-Walk 10 feet (3 meters),
-Turn around,
-Walk back,
-Sit down

Balance test: YES NO

(1) Side-by-side, stable 10 sec ☐ ☐

(2) Semi-tandem, stable 10 sec ☐ ☐

(3) Full tandem, stable 10 sec ☐ ☐

Balance test
(1) side-by-side: feet side by side, touching;
(2) Semi-tandem: side of the heel of one foot touching the big toe of the other;
(3) tandem: heel of one foot directly in front of and touching the toes of the other foot.
Each stance is progressively more difficult to hold. People unable to hold a position for 10 seconds are not asked to attempt further stands

Tick if abnormal

	STRENGTH		TONE	
	Left	Right	Left	Right
ARM				
LEG				

Quadriceps strength: can rise from chair without using arms Yes ☐ No☐
Treatment (to be completed by the doctor):
1-
2-

الاداة ٧ (tool7) أنشطة تقييم الحياة اليومية

الغاية منه	تقييم الحياة اليومية
يتم بواسطة	ممرض أو ملاك رعاية صحية مدرب أو طبيب
كم يستغرق	١٠ دقيقة

نوع النشاطات ٠-٦	المريض يستطيع اداء النشاط باستقلال كامل ١	المريض يستطيع اداء النشاط بمساعدة الاخرين /او لا يستطيع بالمطلق٠
الحركة النقاط -------	يتحرك داخل وخارج البيت بدون مساعدة استعمال الكرسي المتحرك او المساعدات الحركية مقبول ١	يحتاج مساعدة مساعدة للحركة من السرير الى الكرسي اويحتاج الى مساعدة كاملة في التحرك ٠
تناول الطعام النقاط-----	تناول الطعام من الصحن الى الفم بدون مساعدة تحضير الطعام قد يكون من قبل شخص اخر ١	يحتاج الى مساعدة جزئية او كلية لتناول الطعام ٠
الاستحمام النقاط-----	ياخذ حمامه بصورة مستقلة كاملا او يحتاج الى مساعدة في بعض اجزاء جسمه ١	يحتاج الى مساعدة في اخذ حمامه لاكثر من جزء من جسمه او يحتاج مساعدة في الخروج من حوض الاستحمام اويحتاج الى حمام كامل بوجود الاخر ٠
ارتداء الملابس النقاط-----	اخذ الملابس من الدولاب وارتدائها كليا قد يحتاج مساعدة في ربط الحذاء ١	يحتاج مساعدة في لبس الملابس جزئية اوكلية ٠
الذهاب الى المرافق الصحية النقاط-----	الذهاب الى المرافق نزع وارتداء الملابس الداخلية تنظيف المنطقة ١	يحتاج مساعدة للذهاب الى التواليت ، تنظيف المنطقة او استعمال الحفاظات ٠
التحكم بالادرار والتغوط النقاط-----	سيطرة ذاتية كاملة على الادرار والتغوط ١	عدم سيطرة كلية او جزئية على الدرار او التغوط ٠

مجموع تقييم انشطة الحياة اليومية:

مستقل (٦) يحتاج مساعدة (١-٥) معتمد كلياً(٠)

٣-تقييم السريري والعلاجي للامراض المزمنة
ارتفاع ضغط الدم والسكري

Hypertension & Diabetes

1- Management of hypertension in elderly

- Definition of old adult patients ≥60 years, while very Old ≥80 years.
- The prevalence of arterial hypertension is constantly rising, mainly as the result of the aging of the population, in particular the increase in the population over 80 years old, which has expanded.
- Until the age of 50 to 60 years, both SBP and DBP increase with age. Over the age of 60 years, in the majority of cases, SBP increases with age, whereas DBP concomitantly remains stable or even decreases spontaneously. Arterial stiffness is the major cause of elevated systolic BP (SBP) and pulse pressure (PP) which are better indicators of CVD risk in older subjects. In addition an association between elevated BP and the risk of cognitive impairment was observed.
- In old subjects with suspected hypertension, a thorough history, physical examination, and a limited number of selected laboratory a complementary exams should be performed, to confirm the presence of a permanent BP elevation, exclude a secondary hypertension and evaluate the global CVD risk.
- Among other causes of secondary hypertension, medication related BP elevation should always be investigated. Patients should specifically be questioned on use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, nasal decongestants, corticosteroids, hormone replacement therapy, ephedrine-containing supplements, and other over the counter preparations, which many patients do not view as medication and fail to mention their use unless specifically asked.
- Resistant hypertension may also be because of nonadherence (eg, because of cognitive decline), and possible causes should be appropriately investigated.

Evaluation of patients >80 years, physicians must take into account that managing old patients is time-consuming because of multiple comorbidities, physical and cognitive slowness of older people, and the fact that most of the time, old frail subjects are accompanied by family members and professional with whom

Physician have to discuss several issues

- The diagnosis of hypertension should be based on at least 3 different BP measurements, taken on 2 separate office visits at sitting position. BP change from supine to upright position should be systematically measured in older hypertensive subjects independently of symptoms such as dizziness, falls, or syncope.

- A shared decision-making with regard to the treatment plan, which favors safety and adherence, requires detailed explanations not only at initiation but also repeatedly during follow-up.
- For people 60 years old a BP ≥140/90 mmHg, while for very Old over 80 years a BP ≥150/90 mmHg considered HT. A BP goal of <140/90 mm Hg for individuals older than 60 years, and a target of BP <150/90 mm Hg for those over 80 years. Moderate HT is over 160/100 and sever HT over 180/110.
- Life style modification is essential initially, and reinforced at every visit, including; diet preferably **DASH diet** which is a diet recommended for people who want to prevent or treat hypertension, and reduce their risk of heart disease, it is rich in fruits, vegetables, fat free or low fat milk and milk products, whole grains, fish, poultry, beans, seeds and nuts. It also contains less sodium, sweets, added sugars, and beverages containing sugar, fats, and red meats. This heart healthy way of eating is also lower in saturated fat, trans fat and cholesterol and rich in nutrients that are associated with lowering blood pressure- mainly potassium, magnesium, calcium, protein and fiber. Also exercise, weight control, salt restriction, stop smoking, and alcohol moderation.
- After 3 months of life style therapy in mild HT fail to achieve goals, or if moderate HT at start, pharmacotherapy can be added.

- Most international guidelines propose the same 5 antihypertensive drug classes as for younger subjects as initial therapy, choice depend on associated clinical features, cost and availability: thiazide diuretics, calcium channel blockers (extended release), angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, angiotensin receptor blockers

- (ARB), and beta blockers (BB) in those with compelling conditions (HF, Angina, post MI, arrhythmia).
- If goal is not achieved increase dose or combination antihypertensive therapy to control BP should be considered in the course of treatment only if the indication seems relevant after a judicious benefit/risk assessment.
- Recheck every 3 months if BP is controlled and therapy is reevaluated if needed. If had resistant to therapy refer to specialist.
- It is important to regularly check for all potential clinical and biological side effects and the impact of these treatments on the functional status and quality of life of the older patients.

2- Management of type 2 diabetes in elderly

- The prevalence of type 2 diabetes continues to increase steadily as more people live longer and grow heavier. Older adults (>65 years) with diabetes are at risk of developing a similar spectrum of microvascular complications as their younger counterparts with diabetes, while their risk for macrovascular complications is substantially higher than for younger people with diabetes.
- In addition, they are at high risk for polypharmacy, functional disabilities, and common geriatric syndromes that include cognitive impairment, depression, urinary incontinence, falls, and persistent pain.
- In frail older patients with diabetes, avoidance of hypoglycemia, hypotension, and drug interactions due to polypharmacy are of even greater concern than in younger patients with diabetes. Goals for glycemic control, as well as risk factor management, should be based upon the individual's overall health (specifically, serious comorbidities, cognitive functions, and functional status) as it impacts the life expectancy and risk of complications
- For the diagnosis of diabetes, same steps for standards in type 2 diabetes taken.
- It is important to note that the measurement of A1C may not be accurate in several situations that are seen frequently in older adults. These include anemia and other conditions that impact red blood cell life span, chronic kidney disease, recent transfusions and erythropoietin infusions, recent acute illness or hospitalizations, and chronic liver diseases.

- In fit older populations and in those with life expectancy of >10 years, an A1C goal of <7.5 percent should be considered in medication-treated patients. To achieve this goal, fasting and pre-prandial glucoses should be between 140 and 150 mg/dL.
- Individualized goals for the very old (eg, frail patients unable to provide self-care) may be even higher (A1C <8.5 percent) and should include efforts to preserve quality of life, avoid hypoglycemia and related complications, and severe hyperglycemia (eg, >350 mg/dL)
- Hyperglycemia increases dehydration, impairs vision and cognition, and increases risk of infections, all of which contribute to functional decline and an increased risk of falling in older diabetic patients. Hypoglycemia, can result in poor outcomes, such as traumatic falls and exacerbation of comorbid conditions.
- Older adults may have more neuroglycopenic manifestations of hypoglycemia (dizziness, weakness, delirium, confusion) compared with adrenergic manifestations (tremors, sweating), resulting in delayed recognition of hypoglycemia.
- Older patients are more likely to derive greater reduction in morbidity and mortality
- from cardiovascular risk reduction, particularly treatment of hypertension and lipid lowering with statin therapy, than from tight glycemic control. Smoking cessation, Aspirin therapy and Exercise are important considerations.
- The relative beneficial effects of lipid lowering with statins are similar in older and younger patients with diabetes, and the absolute benefit is typically greater in older than in younger patients.
- The initial treatment of type 2 diabetes in older patients is similar to that in younger patients and includes counseling on nutrition, physical activity, optimizing metabolic control, and preventing complications. Weight reduction (if needed) through diet, exercise, and behavioral modification can be used to improve glycemic control, although the majority of older patients with type 2 diabetes will require medication over the course of their diabetes.
- Stop smoking and moderation of alcohol is of most importance.

- For older patients who are not controlled on lifestyle for 3 months and do not have contraindications to metformin (eg, kidney impairment (eGFR) <45 mL/min] or unstable or acute heart failure at

- risk of hypoperfusion and hypoxemia, we suggest metformin as initial therapy (dose 500-2000 depending on renal function).
- Insulin can also be considered as initial therapy for patients with type 2 diabetes, particularly patients presenting with A1C >9 percent, fasting plasma glucose >250 mg/dL , random glucose consistently >300 mg/dL , or ketonuria. Once insulin sensitivity is restored, the dose can be lowered or replaced with metformin or another oral hypoglycemic agent with lower risk of hypoglycemia.
- Glibinclamide, glimepiride, or gliclazide for initial therapy. Better to avoid the use of long-acting sulfonylureas (eg, glibinclamide) in older adults due to higher risk of hypoglycemia if possible or start with very low dose (1.25 mg daily).
- Other drugs that used as initial or addon therapy in older adults include repaglinide and DPP-4 inhibitors, thiazolidindions and SGL2 I. The choice of therapy should be individualized based upon patient characteristics, preferences, and costs. Usually patient need referral to secondary or tertiary center in this case.
- Insulin initiation is sometimes underutilized in older adults because of fear that it is too complicated or dangerous. With the availability of long-acting insulins, it has become easier to use once-daily, long-acting insulin as monotherapy or add once-daily insulin to oral hypoglycemic medications in older patients who have suboptimal glycemic control. Before beginning insulin therapy, it is important to evaluate whether or not the patient is physically and cognitively capable of using an insulin pen or drawing up and giving the appropriate dose of insulin (using syringes and vials), monitoring blood glucose, and recognizing and treating hypoglycemia. Usually patient need referral to secondary or tertiary center in this case.
- Drug induced hypoglycemia is most likely to occur in the following circumstances in

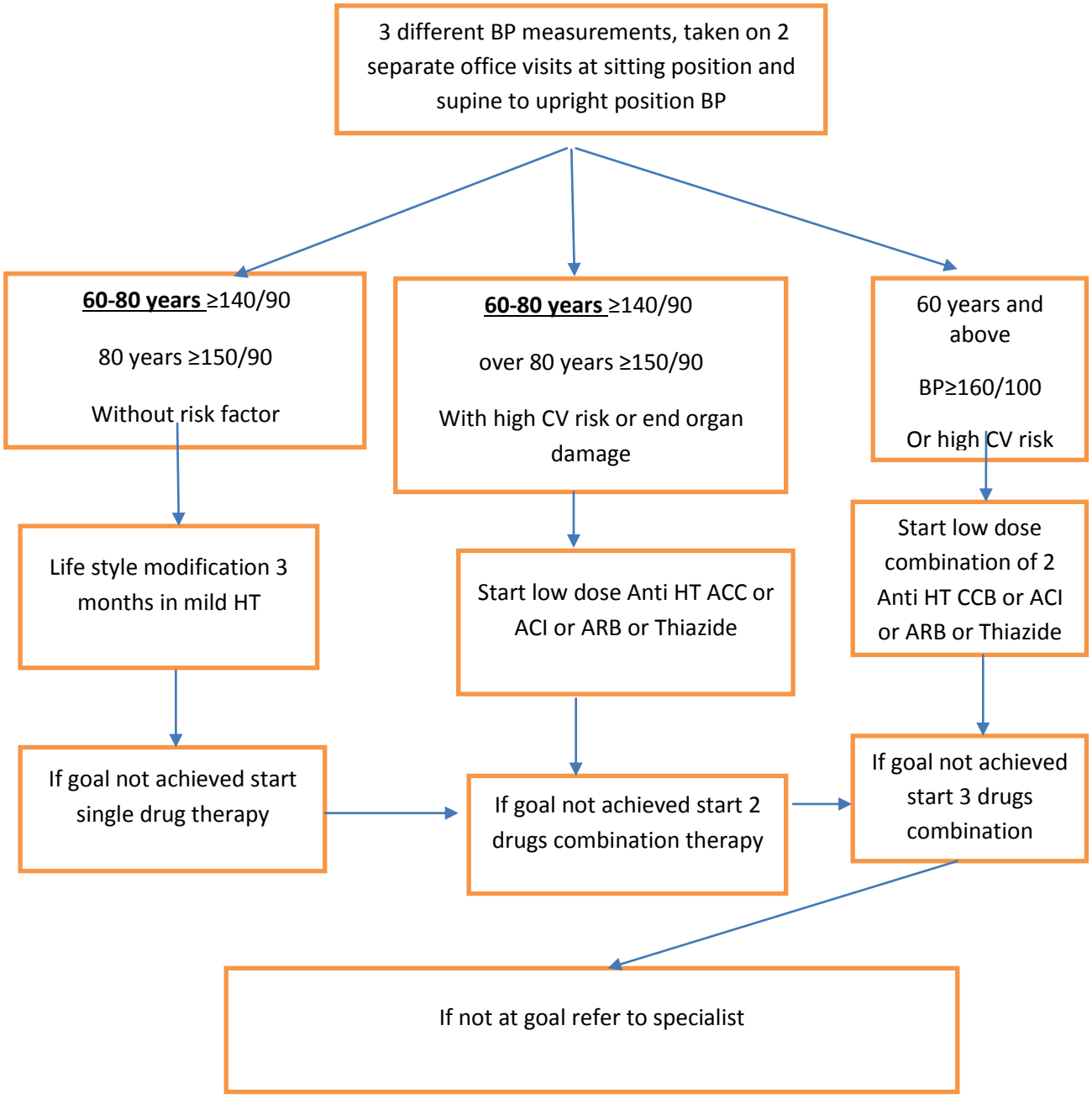
- older patients and may be a limiting factor for use of these drugs in older adults: After exercise or missed meals, When they eat poorly or abuse alcohol, When they have impaired kidney or cardiac function or intercurrent gastrointestinal disease and During therapy with

-

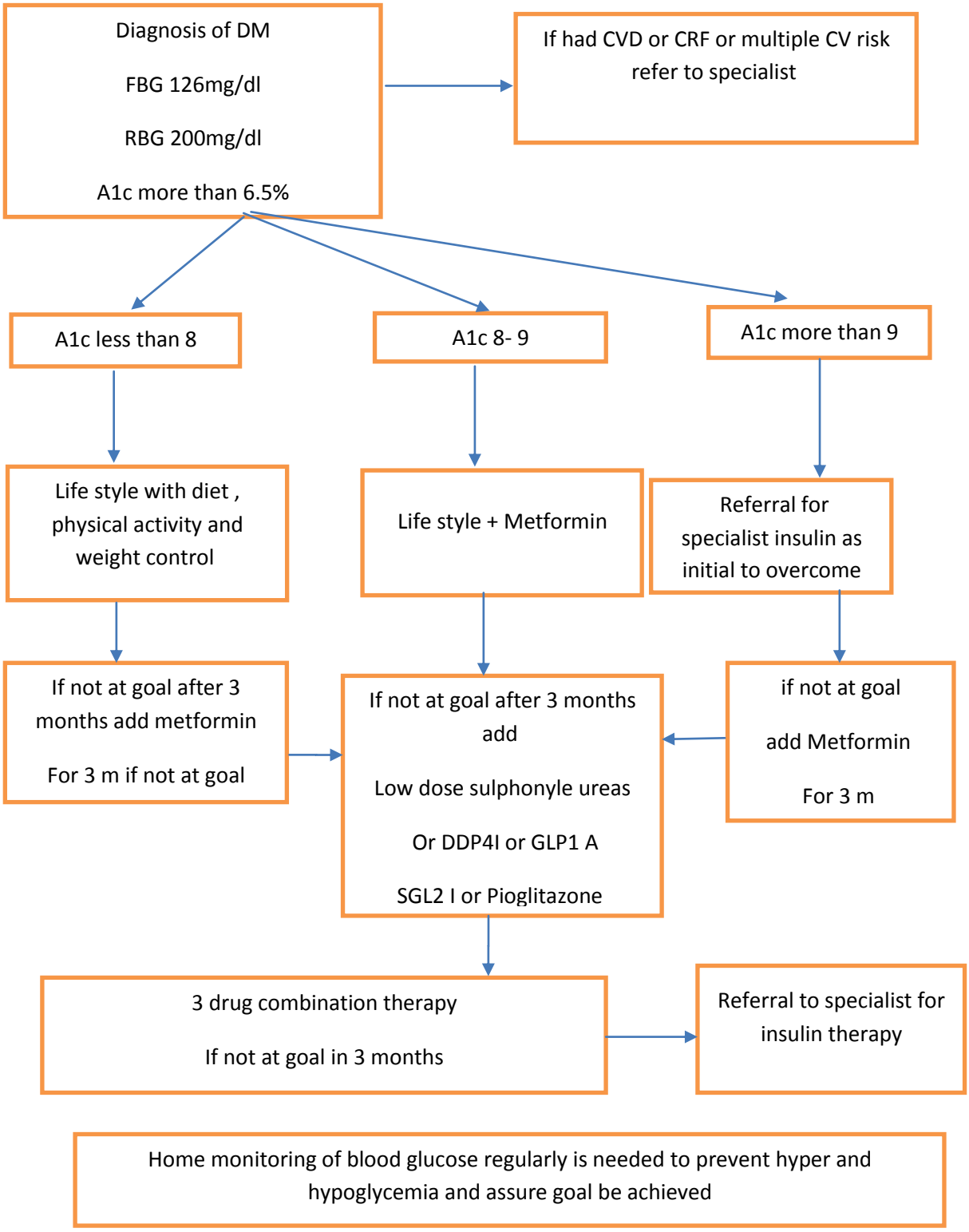
- salicylates, sulfonamides, fibric acid derivatives (such as gemfibrozil), and warfarin.
- Monitoring A1C twice yearly in older patients who are meeting treatment goals and who have stable glycemic control, and quarterly in patients whose therapy has changed or who are not meeting their glycemic goals.
- Blood glucose concentrations can also be monitored at home by the patient or a caregiver. Self-monitoring of blood glucose (SMBG) should be considered in older patients, depending upon medications and functional and cognitive ability.

INTIATION OF TREATMENT FOR HYPERTENSION IN OLDER PEOPLE

Management of HT in elderly Algorithm



Management of diabetes in elderly algorithm



استمارة الاشراف المركزي والمحلي
للمركز الصحي الودي للكبار

اسم الدائرة :
اسم القطاع :
اسم المركز الودي :
تاريخ الزيارة :
الدرجة القياسية (٢٨) الدرجة الفعلية ( ) النسبة المئوية (الفعلي/القياسي×١٠٠)

فعال(٧٥%-١٠٠%) ☐ **فعال جزئي(٧٤%-٥٠%)** ☐ **غير** ☐

اولاً	الشروط الواجب توفرها	مطبق (٢) ٧٥%-١٠٠%	مطبق جزئي (١) ٥٠%-٧٤%	غير مطبق (٠) ٤٩% او اقل	الملاحظات
١-	وجود لوحة (لافتة) تبين ان المركز الصحي ودي لكبار السن				
٢-	توفركراسي متحركة لمن لايستطيع المشي توضع في اماكن الاستعلامات ونقاط الاستقبال لنقل المرضى الى خدماتهم				
٣-	توفير RAMP (منحدر) في المداخل الخاصة بالمراجعين نسبة ١:٠٨ او ١:٢٠				
٤-	توفير مقابض HAND RAIL مساند لمساعدة المرضى الكبار على المشي في الممرات				
٥-	توفر لوحات دلالة داخل المركز الصحي يساعد على توجيه وارشاد المرضى				
٦-	وجود لوحات تثقيفية داخل المركز الصحي تخص صحة رعاية الكبار				
٧-	الاضاءة الجيدة في كافة انحاء المركز الصحي تسهم في توفير الراحة النفسية والجسدية للمراجعين الكبار				
٨-	توفير مصاطب جلوس (يفضل ان تكون ثابتة) بعدد مناسب في مناطق الانتظار				
٩-	وجود حمامات غربية او مقعد غربي متحرك في الحمامات				
١٠-	وجود اولوية واسبقية للكبار في مراجعة الطبيب وفي الفحوصات الطبية				
١١-	توفر وسائل التوعية والفولدرات الخاصة بالمواضيع ذات العلاقة بصحة وسلامة الكبار				
ثانياً	**تدريب جميع العاملين في المركز الصحي على خدمات رعاية الكبار**				
١-	تدريب اطباء المركز الودي (على الاقل ٢ اطباء)				
٢-	تدريب الملاكات الصحية (على الاقل ٣ ملاكات صحية)				
٣-	تدريب الملاكات الاخرى(على الاقل ٣ اشخاص)				

فعال(٤٩%اواقل)

اسماء الفريق المشرف : **ختم المركز الودي المزار**

فيروس كورونا وكبار السن

ان كبار السن معرضين للاصابة بمرض وخيم عند التعرض لفيروس كورونا وان ٩٥% من الوفيات تحدث في كبار السن الذين اعمارهم ٦٠ سنة فما فوق. وان ٥٠ % من الوفيات تحدث في الاعمار ٨٠ سنة فأكثر.

كذلك فأن ٨ الى ١٠ من الوفيات تحدث عند الاشخاص الذين لديهم على الاقل مرض مزمن واحد كأمراض القلب والضغط والسكري وغيرها.

ان منظمة الصحة العالمية اعطت ٣ نصائح فيما يتعلق بكوفيد ١٩ لحماية ورعاية ودعم كبار السن:

أولاً ، يجب أن نؤكد أنه في حين أن كبار السن هم الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بـ كوفيد -١٩ ، فإننا جميعًا ، في جميع الأعمار ، بحاجة إلى العمل بشكل متضامن لمنع انتشار الفيروس في المجتمع.

ان بعض الاسباب التي تجعل كبار السن معرضين لخطر الاصابة بفيروس كورونا هي التغييرات الفزيولوجية المتعلقة بتقدم العمر، نقص المناعة، وتعدد الامراض المزمنة التي تجعلهم معرضين اكثر للاصابة بمرض وخيم وللمضاعفات الخطرة منه.

ثانيا أهمية دعم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية على قدم المساواة وإيلاء اهتمام خاص لمن يقدمون خدمات التمريض والرعاية الاجتماعية لكبار السن: عدم ترك أحد يتخلف عن الركب.

تواصل منظمة الصحة العالمية التأكيد على أهمية حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية. ١٠٪ من مرضى كوفيد-١٩ هم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. يجب دعمهم بالتدريب والموارد التي يحتاجون إليها ، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية المناسبة. هذا مهم بنفس القدر لأولئك الذين يقدمون الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن الذين يعيشون في مجتمعاتهم أو في مرافق الرعاية طويلة الأجل. هؤلاء هم زملائنا الذين يهتمون بمن هم من بين أكثر الفئات ضعفاً: الأشخاص الذين يعانون من الضعف والمصابين بالخرف.

ثالثًا ، دعم وحماية كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في المجتمع هو عمل الجميع.

إنني أذكّر الحكومات والسلطات بضرورة دعم جميع المجتمعات لتقديم التدخلات لضمان حصول كبار السن على ما يحتاجون إليه. يشمل هذا الدعم الوصول الآمن إلى الأغذية والإمدادات الأساسية والمال والأدوية لدعم الصحة البدنية والحصول على الدعم الاجتماعي والصحي العقلي. يجب معاملة جميع كبار السن باحترام وكرامة خلال هذه الأوقات. تذكر ، نحن لا نترك أحدًا خلفنا.